**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria**

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari3vciv@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5030104-75.2022.8.21.0027/RS**

**AUTOR**: MARCUS VILLANOVA FRANCESQUETTO

**RÉU**: UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

# SENTENÇA

Vistos.

**MARCUS VILLANOVA FRANCESQUETTO**, representado por sua genitora CHAIANA RODRIGUES VILLANOVA, ajuizou *ação de relação de consumo - fornecimento de tratamento/medicamento c/ pedido liminar* em face de **UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA**, qualificados na inicial. Relatou ser portador de dermatite atópica (CID-10 L20) há sete anos, sendo o seu quadro bastante grave, com lesões por todo o corpo, pruridos e episódios de infecção. Destacou trechos do laudo médico que destacam os impactos da doença em sua vida. Contou ter solicitado ao plano de saúde conveniado o fornecimento do tratamento, o que foi negado. Discorreu sobre o direito aplicável ao caso. Argumentou o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória. Ao final, pediu a procedência da demanda, com a condenação da parte requerida a autorizar e a disponibilizar o seu tratamento. Solicitou AJG. Juntou documentos (demais documentos do Evento 1).

Intimado o autor para comprovar a necessidade de AJG (evento 4, DESPADEC1), este acostou documentos (evento 7, DECL2 e evento 7, DECL3).

Indeferida a AJG ao autor e intimado para o pagamento das custas iniciais (evento 9, DESPADEC1).

O autor requereu a reconsideração da decisão (evento 12, PET1), o que não foi acolhido (evento 14, DESPADEC1).

Interposto agravo de instrumento (Evento 16) e reformada a decisão, com a concessão da AJG ao autor (processo 5198952-58.2022.8.21.7000/TJRS, evento 5, DECMONO1).

Intimado o autor para emendar a inicial (evento 20, DESPADEC1).

Comparecendo espontaneamente aos autos, a parte requerida apresentou contestação (evento 30, CONT1). Preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa. Falou que a negativa de fornecimento é devida já que o medicamento pretendido não está no rol da ANS. Discorreu sobre a legislação que regula os planos de saúde privados. Referiu que o medicamento possui diretrizes de utilização e que não há indicação para tratamento do caso do autor, mas sim para asma eosinofílica grave. Defendeu que não cabe ao Poder Judiciário interferir no rol de procedimentos que constituem a cobertura mínima obrigatória, sob pena de desequilíbrio contratual. Requereu a improcedência da demanda. Juntou documentos (demais documentos do Evento 30).

O autor emendou a inicial (evento 31, PET1).

Deferido o pedido de tutela provisória, esclarecida a não designação de audiência de conciliação e intimado o autor para réplica (evento 34, DESPADEC1).

A requerida comprovou o cumprimento da tutela (evento 39, PET1 e evento 39, OUT2).

Intimadas as partes para se manifestarem acerca das questões de fato e de direito importantes para o julgamento da lide, bem como sobre o interesse na dilação probatória (evento 43, ATOORD1).

O autor postulou a produção de prova pericial e a juntada de documentos (evento 47, PET1, evento 47, LAUDO2, evento 47, OUT3 e evento 47, OUT4).

A requerida informou seu desinteresse na produção de outras provas (evento 48, PET1).

O autor solicitou a prorrogação do prazo da liminar deferida (evento 49, PET1), o que não foi, por ora, analisado (evento 51, DESPADEC1).

Intimado o autor para juntar laudo médico e indeferido o pedido de prova pericial (evento 60, DESPADEC1).

O autor acostou laudo médico (evento 63, PET1 e evento 63, ATESTMED2).

O Ministério Público opinou pela intimação do autor para regularização de sua representação processual, pela rejeição da impugnação ao valor da causa nos termos formulados pela requerida e pela sua retificação, bem como pela procedência da ação e confirmação da tutela provisória (evento 69, PROMOÇÃO1).

Intimado o autor para regularizar sua representação processual (evento 73, DESPADEC1), o que foi atendido (evento 76, PROC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

**É o relatório. Decido.**

Inicialmente, consigno que o contrato de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com orientação pacificada, inclusive, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Súmula 608[1].

Havendo questão preliminar, passo à sua análise.

A parte requerida impugnou o valor da causa, pois argumenta que o valor de R$ 50.000,00 seria "aleatório e impreciso", requerendo sua retificação para o valor da alçada ou, alternativamente, para o valor equivalente a 12 vezes a mensalidade do plano de saúde do autor.

Por sua vez, o Ministério Público opinou a retificação para o valor correspondente a 12 meses de tratamento.

No ponto, a preliminar suscitada merece prosperar e assiste razão ao Ministério Público, uma vez que o proveito econômico da demanda é mensurável, sendo que a jurisprudência dos tribunais superiores aponta que para a quantificação do valor da causa deve-se levar em conta os custos referentes a 12 meses do uso do medicamento.

Nesse sentido:

> *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESACOLHIMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. MEDICAMENTOS DRABAFENIBE E TRAMETINIBE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CASO CONCRETO. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA.*
>
> *I. **IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, CONSIDERANDO QUE NÃO HÁ PRAZO ESPECÍFICO PARA O TÉRMINO DO TRATAMENTO MÉDICO, O VALOR DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS DEVE SER IGUAL A UMA PRESTAÇÃO ANUAL, NA FORMA DO §2º DO ART. 292 DO CPC. LOGO, SOMANDO-SE O VALOR DA PRESTAÇÃO ANUAL DOS MEDICAMENTOS AO MONTANTE PRETENDIDO NA PETIÇÃO INICIAL A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DO ART. 292, IV E V, DO CPC, CHEGA-SE EXATAMENTE AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA PELA PARTE AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA.***
>
> *[...]*
>
> *(TJ/RS. Apelação cível nº 50088853820208210039, Quinta Câmara Cível, Publicação: 26/11/2021, Julgamento: 26 de Novembro de 2021, Relator: Jorge André Pereira Gailhard) **(grifei)***

Assim, consigno que se tratando de demanda em que não há prazo específico para o término do tratamento com a medicação, aplica-se o disposto no § 2º do art. 292 do CPC[2], tomando o valor das prestações vincendas como o valor da prestação anual do medicamento.

Para tanto, consta nos autos valor de referência do medicamento apontado na Nota Técnica acostada (evento 31, OUT2), sendo Preço Máximo de Venda ao Governo igual a R$ 6.273,41.

Tendo em vista que o autor faz uso de uma seringa de 300mg a cada 14 dias (evento 1, RECEIT7), ou seja, uma caixa do medicamento (contendo duas seringas) com duas aplicações ao mês, o custo anual do tratamento com o Dupilumabe é estimado em R$ 81.554,33, levando em consideração a semana 0 (duas seringas, R$ 6.273,41) e a manutenção mensal do medicamento (12 meses x R$ 6.273,41).

Assim, em observância ao previsto no §3º do art. 292 do CPC/2015[3], retifico o valor da causa para R$ 81.554,33, já atualizado no sistema.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito da lide.

Da análise do caderno processual, sinalo, desde já, que a demanda prospera, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

No caso, trata-se de fato incontroverso que a parte demandada ofereceu negativa de cobertura do medicamento reclamado (evento 1, OUT8), todavia, também restou incontroversa a necessidade do medicamento pela parte demandante e do seu uso contínuo para a sua qualidade de vida (evento 1, LAUDO6), além da expressa recomendação médica para aplicação em ambiente ambulatorial (evento 63, ATESTMED2).

Sendo assim, como bem aponta a parte ré em sua contestação, tratando-se de demanda em que há conflito derivado do interesse econômico e em que há discussão acerca do direito à saúde da parte demandante, é dever do Juiz analisar cada demanda com a parcimônia e cuidado que lhes é inerente.

Neste caso, há que se destacar que o contrato prevê cobertura para a patologia que acomete o autor, qual seja, a dermatite atópica, bem como o tratamento necessário está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não podendo haver negativa de cobertura somente porque o medicamento "possui diretrizes de utilização".

Inclusive, em 02/04/2024 foi incluída no rol da ANS a ampliação do uso do medicamento Dupilumabe para tratamento de dermatite atópica[4], sendo obrigatório o fornecimento pelos planos de saúde desde que preenchidos os critérios de elegibilidade, quais sejam:

**(1)** Laudo médico que indique se tratar de paciente *"sem resposta adequada a tratamento tópico com corticosteroide e/ou inibidores de calcineurina por pelo menos 6 meses"* e

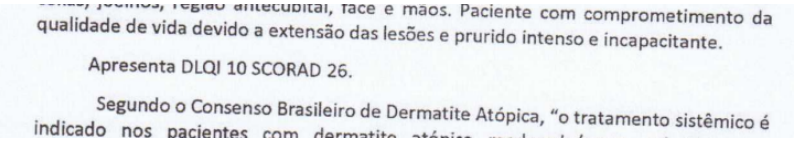
**(2)** Índice de Gravidade da Dermatite Atópica (SCORing Atopic Dermatitis) - SCORAD superior a 50;

OU Índice de Severidade e Área de Eczema (Eczema Area and Severity Index) - EASI superior a 21;

OU Índice de Qualidade de Vida em Dermatologia (Dermatology Life Quality Index) - **DLQI superior a 10**;

OU Índice Pediátrico de Qualidade de Vida em Dermatologia (Children's Dermatology Life Quality Index- CDLQI superior a 12.

No caso do autor, o laudo médico indicou tratar-se **DLQI Scorad 26** (evento 1, LAUDO6):


qualidade de vida devido a extensão das lesões e prurido intenso e incapacitante.

Apresenta DLQI 10 SCORAD 26.

Segundo o Consenso Brasileiro de Dermatite Atópica, "o tratamento sistêmico é indicado nos pacientes com dermatite

Dessa forma, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano, indicado pelo médico especialista e cujo uso foi não só ampliado no rol da ANS como também previsto para cobertura obrigatória.

Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento de demais casos similares:

> ***AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SEGURADO DO IPE-SAÚDE. MEDICAMENTO DUPILUMABE. DEVER DE FORNECIMENTO CARACTERIZADO.*** *1. Em que pese o artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/18, que revogou a Lei nº 12.134/04, disponha que integram o plano de saúde atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos, exceto os tratamentos não previstos nas tabelas do próprio Instituto,* ***o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é cristalino quanto à impossibilidade do plano de saúde eleger as espécies de tratamento fornecidos ao segurado. Logo, descabe interpretação restritiva, pois a responsabilidade quanto ao fornecimento do tratamento indicado, a fim de possibilitar o tratamento ao paciente - segurado, está atrelada ao que dispõe o referido artigo 2° da Resolução nº 21/1979, ou seja, "os atos necessários ao diagnóstico ou tratamento".*** *Relembro, ademais, que a fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida – maior bem de todos –, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o sentido.* ***2. A prova constante dos autos dá conta da indicação médica para tratamento vindicado, sob risco de morte da paciente, restando cogente a manutenção da condenação ao fornecimento do medicamento. Por outro lado, diante da identidade axiológica da questão presente com o REsp 1.657.156-RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 25/04/2018, referente ao Tema 106, em face da semelhança dos direitos em conflito, imperioso exigir-se, para medicamentos fora da lista dos fornecidos pelo IPE-SAÚDE, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da (a) imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pela autarquia, e a (b) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).*** *3. In casu, depreende-se do laúdo médico que, apesar de usar outros fármacos, é imprescindível o uso do medicamento pleiteado para o tratamento da enfermidade do autor. Demais, a própria nota técnica emitida pelo NatJus para o presente caso demonstra que,* ***além de o fármaco estar registrado na ANVISA****, a conclusão foi favorável para o referido tratamento, tendo destacado a urgência da medida. Logo, merece prosperar a pretensão recursal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51014011020248217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 17-07-2024)* ***(grifei)***
>
> *AGRAVO DE INSTRUMENTO.* ***SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.*** *PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.* ***AGRAVANTE PORTADORA DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE. PEDIDO DE COBERTURA DO MEDICAMENTO DUPILUMABE.*** *É LÍCITA A EXCLUSÃO, NA SAÚDE SUPLEMENTAR, DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUELES PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DE UNIDADE DE SAÚDE, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (E CORRELACIONADOS), A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) PARA ESSE FIM.* ***NO CASO EM EXAME, O FÁRMACO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE E REFRATÁRIA CONSTA DA RN-ANS Nº 465/2021 COMO MEDICAMENTO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA O TRATAMENTO DA CONDIÇÃO, DE MODO QUE DEVE SER CUSTEADO PELO PLANO DE SAÚDE.*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.(Agravo de Instrumento, Nº 53884946120238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Redator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-04-2024)*
>
> ***APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT®). DERMATITE ATÓPICA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ 1) Trata-se de ação de obrigação de fazer, através da qual a parte autora busca cobertura para o tratamento de dermatite atópica (CID 10 L20.9) com medicamento denominado DUPILUMABE (Dupixent®), 200mg, a ser administrado em ambiente ambulatoria, visto que subcutâneo, julgada procedente na origem.*** *2) A Lei nº 14.454/22 estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, utilizando dois parâmetros semelhantes aos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para excepcionar a taxatividade do rol (EREsp 1886929 e EREsp nº 1889704). 3) Das condicionantes fixadas pela Corte Superior para excepcionar o Rol da ANS, remanescem as constantes nos itens "ii" e "iii" - (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; e (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros. 4) Segundo entendimento do egrégio STJ, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.* ***5) No caso em comento, o tratamento indicado se trata de medicação imunobiológica endovenosa ou subcutânea e tem cobertura prevista no Rol da ANS para Dermatite Atópica, conforme previsto no Anexo II da RN nº 465/21, na Diretrizes de Utilização (DUT). 6) Sem razão a negativa de cobertura, visto que o medicamento, objeto da lide está incluído no rol da ANS.*** *Sentença mantida, no ponto. 7) O egrégio Superior Tribunal de Justiça concluiu, a partir do julgamento do TEMA 1076, que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Da mesma forma, definiu que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Ficou sedimentado, ainda, o entendimento que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 8) Em alinhamento com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, fora publicada a recente Lei Federal n. 14.365, em 03/06/2022, que trouxe*

*alterações ao CPC, com a inclusão do parágrafo 6º-A ao artigo 85, o qual veda de forma taxativa a aplicação da fixação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa for líquido, ou liquidável. 9) Assim, o recurso da parte autora resta provido, para fim de ser fixada a verba honorária na forma do art. 85, § 2°, do CPC. DUPLA APELAÇÃO. APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO(Apelação Cível, Nº 50024811720228210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 29-02-2024).* ***(grifei)***

Ademais, mesmo ajuizada ligeiramente antes à entrada em vigor da Lei nº 14.454/22, vejo que a parte autora comprovou a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas (evento 31, OUT2, evento 31, OUT3, evento 31, OUT4, evento 31, OUT5 e evento 31, OUT6) e em plano terapêutico do medicamento ora pleiteado[5] (evento 1, LAUDO6):

> Sabemos que a dermatite atópica acarreta grande impacto na qualidade de vida do paciente, apresenta curso crônico e prurido intenso, podendo causar perda de sono, perda de dias de trabalho, faltas escolares, isolamento social, depressão e ideações suicidas.

Além do fármaco postulado na exordial ter sido prescrito pelo médico que trata o autor, no caso concreto há expressa recomendação para que o medicamento seja aplicado em ambiente ambulatorial (evento 63, ATESTMED2), sendo cediço que em tais casos é obrigatório o fornecimento do medicamento pelo plano de saúde.

Com isso, considerando a imprescindibilidade do fármaco, deve prevalecer a cobertura contratual, sob pena da cláusula ser considerada abusiva ou ser interpretada de forma restritiva à luz do artigo 54[6] do Código Consumerista.

Dessa forma, por vários ângulos resta configurada a obrigação da administradora do plano de custear o medicamento, porquanto cabe ao profissional médico prescrever qual o melhor tratamento ao seu paciente.

Para não passar em branco, em que pese a parte ré faça menção genérica acerca da existência de alternativas medicamentosas com a mesma eficácia para tratamento da doença que acomete o autor, não há nenhum elemento a dar amparo a tal alegação.

Destarte, pelas razões expostas, ratifico a tutela provisória de urgência deferida (evento 4, DESPADEC1), sinalando a procedência do pedido lavrado na inicial.

ISSO POSTO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, **julgo procedente** o pedido da inicial, para o fim de **ratificar** a tutela provisória de urgência deferida (evento 34, DESPADEC1) e **condenar** a ré a fornecer o medicamento Dupilumabe 300mg, conforme prescrição médica, na posologia de uma seringa a cada 14 dias (evento 1, RECEIT7), **enquanto perdurar a necessidade do autor**, sem prejuízo de mudança da posologia, de acordo com prescrição médica.

Sucumbente, condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao(s) procurador(es) da parte adversa, os quais fixo no percentual de 10% do valor da causa ora retificado, devidamente corrigido pelo IPCA desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês (sem capitalização), este contados a partir do trânsito em julgado desta decisão, considerando o tempo de duração do processo, o labor do causídico, a natureza e a importância da causa, forte no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Tendo em vista que o §3º do art. 1.010 do CPC/2015 retirou o juízo de admissibilidade deste 1º grau de jurisdição, caso interposto recurso de apelação, caberá ao Cartório, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC/2015.

Idêntico procedimento deverá ser adotado nas hipóteses de recurso adesivo (art. 1.010, §2º, do CPC/2015) e impugnação de decisão interlocutória não agravável trazida nas contrarrazões da apelação (art. 1.009, § 2º, CPC).

Após, concluídas as intimações e decorridos os prazos, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Publicada, registrada e intimadas as partes, automaticamente, via sistema.

---

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ALBERTO ELY FONTELA, Juiz de Direito**, em 27/9/2024, às 17:45:4, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10064235533v37** e o código CRC **15d04b29**.

---

1. Súmula 608 do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. ↩
2. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:(...) § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. ↩
3. Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:(...) § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. ↩
4. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-normativa-ans-n-603-de-1-de-abril-de-2024-551187676 ↩
5. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ↩
6. Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.§ 2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2º do artigo anterior.§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.(Revogado)§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008)§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. ↩